

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'infirmier/infirmière

BRANCHE: COSPI

Etude de cas

DATE :

3 juin 2009

DURÉE :

2 heures

Question I

Mme L. , 36 ans, a subi une hystérectomie planifiée consécutive à la présence d'un volumineux fibrome il y a 4 jours.

Au 2^{ème} jour postopératoire Mme L. s'est plainte de douleurs abdominales et a présenté un ventre ballonné et dur avec signe de défense. Sa température tympanique a été à 38,1° C.

Le chirurgien a diagnostiqué une péritonite et il a décidé de faire une laparotomie exploratrice. Une brèche sur le colon ascendant a été diagnostiquée. Le chirurgien a réséqué la partie atteinte et a mis en place une iléostomie de décharge.

Mme L. a été transférée ce matin de la réanimation (donc 2^{ème} jour postopératoire de la 2^{ème} intervention) dans votre service.

Elle a

- une plaie de laparotomie avec une mèche au niveau de l'ombilic
- une iléostomie appareillée avec une poche vidangeable (système 2 pièces)
- un cathéter veine jugulaire interne droite
- une sonde nasogastrique en aspiration.

Elle reçoit

- Glucose 5% 2000 ml/ 24 heures avec 4 g NaCl /litre et 3 g KCl / litre
(Vous disposez d' ampoules de 10 ml de NaCl 20% et d'ampoules 10 ml de KCl 20%)
- Augmentin 1g toutes les 4 heures dans 100 ml NaCl 0,9%
- Claforan 1g 4 fois par jour dans 100 ml NaCl 0,9% (antibiotique)
- Perfusalgan 1g / 100ml 4 fois par jour en IV
- Clexane 40 mg sc le soir.

1. Pour ce matin les problèmes en collaboration suivants ont été retenus :

- hémorragie
- iléus paralytique
- infection au niveau de la plaie

1.1. Argumentez ces problèmes en collaboration. (8pts)

1.2. Argumentez 2 interventions sur initiative propre pour chaque problème en collaboration (12pts)

Au 3^{ème} jour postopératoire, le transit intestinal ayant repris, la sonde nasogastrique est retirée et une alimentation légère est débutée.

Au 4^{ème} jour postopératoire, Mme L. est nauséuse, vomit et la poche de la stomie ne donne rien.

Elle ne se plaint pas de douleurs.

Le chirurgien prescrit l'arrêt de l'alimentation et la surveillance du transit ainsi qu'un bilan des entrées et des sorties.

Il ajoute pour aujourd'hui 1 amp de Néostigmine (pour stimuler le péristaltisme) 0,5 mg/ml dans 50 ml NaCl 0,9% au traitement médicamenteux qui reste inchangé.

Les paramètres de ce matin :

- T° : 37,6°C
- pouls : 76 battements/'
- TA : 110/ 60 mm Hg

L'infirmière a demandé à Mme L. de recueillir les urines de 24 heures.

2. Argumentez la complication subie par Mme L. (3pts)

Au 5^{ème} jour postopératoire Mme L. n'a plus de nausées.

Sa poche d'iléostomie a été vidée à 6 heures et a donné 650 ml.

La diurèse était à 2700 ml.

Les paramètres de ce matin :

- T° : 37,2° C
- pouls : 72 battements/'
- TA : 110/60 mm Hg

3. Établissez et évaluez le bilan hydrique mesurable. (5 pts)

4. Une des complications possibles au niveau de l'iléostomie est une irritation de la peau péristomale (6pts)

4.1. Argumentez ce problème.

4.2. Énumérez 4 interventions sur initiative propre.

Question II

Mme P., âgée de 55 ans, divorcée sans enfants, a été hospitalisée il y a 3 jours pour un AVC ischémique ayant entraîné une hémiparésie droite. Elle présente une paralysie de la jambe droite, une parésie du bras droit, une paralysie faciale droite, une aphasie et des troubles de la déglutition.

Un orthophoniste est chargé de la réhabilitation de l'aphasie.

Elle a une HTA traitée depuis 6 ans et un diabète type 2 diagnostiqué l'an dernier et traité par antidiabétique oral.

Elle pèse 83 kg pour une taille de 1,65m.

Mme P., droitnière, est couturière. Elle vit avec sa mère âgée de 83 ans, devenue dépendante dans certaines activités de la vie quotidienne depuis la pose d'une prothèse de la hanche. Elles vivent dans un appartement au rez-de-chaussée. Mme P. a vendu son logement pour s'installer chez sa mère et s'occuper d'elle. Mme P. est une personne très dynamique et elle s'est engagée beaucoup pour rendre une vie agréable à sa mère. Pendant l'hospitalisation ce sont le frère et son épouse qui s'occupent de Mme P. et de sa mère.

En ce moment Mme P. est consciente. Elle a encore un repos strict au lit.

Elle présente une aphasie : elle n'arrive pas à s'exprimer, mais comprend ce qu'on lui dit et répond aux ordres simples.

Lors des soins de ce matin Mme P. réagit vivement, car elle voit que ses tentatives de vouloir participer aux soins restent sans effet. Elle pleure, elle émet des sons inarticulés et fait des mouvements de négation de la tête. Elle ne participe plus durant la toilette.

Vous constatez des rougeurs au sacrum et aux talons. Les urines sont très concentrées. Mme L. mange très peu et boit à peine 1L/24heure.

Elle n'a pas encore eu de selles depuis son arrivée à l'hôpital. Il n'y a pas de bruits intestinaux. Lors de l'anamnèse l'équipe soignante a pu comprendre que Mme P. a eu l'habitude d'aller à selle une fois par jour.

- 1. Argumentez l'hypothèse du diagnostic infirmier « sentiment d'impuissance » en vous basant sur les indices présents dans la situation de Mme P. et en les comparant avec ceux du livre. (8pts)**
- 1.2. Expliquez comment vous procéderiez pour confirmer ce diagnostic chez elle. (4pts)**
- 2.1. Indiquez le titre du diagnostic infirmier réel du domaine physique. (1pt)**
- 2.2. Enumérez 3 facteurs favorisants et les caractéristiques de ce diagnostic retrouvés dans cette situation. (5 pts)**
- 2.3. Formulez un résultat escompté (objectif de soins). (2pts)**
- 2.4. Argumentez 3 interventions infirmières. (6 pts)**

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'infirmier/infirmière

BRANCHE: COSPI
Etude de cas

DATE :
3 juin 2009

DURÉE :
2h

FRAGE I

Bei Frau L., 36 Jahre alt, wurde vor 4 Tagen eine geplante Hysterektomie aufgrund eines voluminösen Fibroms vorgenommen.

Am 2. postoperativen Tag beklagte sich Frau L. über abdominale Schmerzen und es wurden ein aufgeblähter Bauch sowie eine Abwehrspannung festgestellt. Die Temperatur betrug 38,1°C (im Ohr gemessen)

Der Chirurg hat eine Peritonitis diagnostiziert und hat sich zu einer Laparotomie entschlossen. Es wurde eine Verletzung am aufsteigenden Kolon diagnostiziert. Der Chirurg hat diesen Teil entfernt und eine Ileostomie zur Entlastung gelegt.

Frau L. ist heute Morgen aus der Intensivstation wieder auf Station aufgenommen worden (2. postoperativer Tag nach 2. Intervention).

Sie hat

- eine Laparotomiewunde mit einer Wunddrainage (mèche) im Nabelbereich
- eine Ileostomie mit zweiteiligem System
- einen Jugulariskatheter rechts
- eine durch die Nase gelegte Magensonde unter Aspiration

Sie erhält:

- Glucose 5% 2000 ml/ 24 Stunden mit 4 g NaCl /Liter und 3 g KCl / Liter
Sie verfügen über Ampullen mit 10ml NaCl 20% und Ampullen mit 10ml KCl 20%
- Augmentin 1g alle 4 Stunden in 100 ml NaCl 0,9%
- Claforan (Antibiotikum) 1g 4 mal pro Tag in 100 ml NaCl 0,9%
- Perfusalgan 1g /100ml 4 mal pro Tag IV
- Clexane 40 mg subkutan abends

- 1. Für den heutigen Morgen wurden folgende Probleme in Zusammenarbeit zurückbehalten:**
 - **Blutung**
 - **Paralytischer Ileus**
 - **Wundinfektion**
- 1.1. Argumentieren Sie diese Probleme in Zusammenarbeit. (8P)**
- 1.2. Argumentieren Sie 2 Pflegemaßnahmen auf Eigeninitiative für jedes dieser Probleme in Zusammenarbeit. (12P)**

Am 3. postoperativen Tag nach Wiederaufnahme der Darmtätigkeit wird bei Frau L. die Magensonde entfernt und sie kann mit leichter Kost beginnen.

Am 4. postoperativen Tag, fühlt Frau L. sich übel, erbricht und der Stomiebeutel ist leer. Sie beklagt sich nicht über Schmerzen.

Der Chirurg verordnet eine Nahrungskarenz, eine Überwachung der Darmtätigkeit und eine Flüssigkeitsbilanz.

Er verordnet zusätzlich für heute 1 Ampulle Neostigmine (zur Darmstimulation) 0,5mg/ml in 50 ml NaCl 0,9%.

Die bestehenden medikamentösen Verordnungen bleiben unverändert.

Parameterwerte von heute morgen:

- T° : 37,6°C
- Puls : 76 Schläge/Minute
- TA : 110/ 60 mm Hg

Die Krankenpflegerin hat Frau L. gebeten den Urin von 24 Stunden aufzubewahren.

- 2. Argumentieren Sie die Komplikation welche bei Frau L. aufgetreten ist. (3P)**

Am 5. postoperativen Tag beklagt sich Frau L. nicht mehr über Brechreiz.

Der Ileostomiebeutel wurde um 6Uhr entleert und hat 650ml enthalten.

Die Diurese betrug 2700ml.

Parameterwerte von heute morgen:

- T° : 37,2°C
- Puls : 72 Schläge/Minute
- TA : 110/ 60 mm Hg

- 3. Erstellen Sie und beurteilen Sie die messbare Flüssigkeitsbilanz. (5P)**
- 4. Eine mögliche Komplikation des Ileostoma ist die parastomale Hautirritation.**
- 4.1. Argumentieren Sie dieses Problem. (2P)**
- 4.2. Nennen Sie 4 Pflegemaßnahmen auf Eigeninitiative. (4P)**

FRAGE II

Frau P., 55 Jahre alt, geschieden, kinderlos, wurde vor 3 Tagen wegen eines ischämischen Hirninsultes mit rechtsseitiger Hemiplegie hospitalisiert.

Sie weist eine Lähmung des rechten Beines, eine Parese des rechten Armes, eine rechte Gesichtslähmung, eine Aphasie sowie Schluckprobleme auf.

Die Aphasie wird von einem Orthophonisten behandelt.

Sie hat seit 6 Jahren eine arterielle Hypertonie, die behandelt wird. Ein Diabetes mellitus Typ 2 wurde vor einem Jahr diagnostiziert und wird mit oralen Antidiabetika behandelt.

Sie wiegt 83 kg bei einer Größe von 1,65m.

Frau P. ist Rechtshänderin und arbeitet als Schneiderin. Sie lebt zusammen mit ihrer 83-jährigen Mutter, die nach dem Einsetzen einer Hüftprothese in verschiedenen Aktivitäten des täglichen Lebens abhängig wurde. Sie leben im Erdgeschoss einer Apartmentwohnung. Frau P. hatte ihre Wohnung verkauft um bei ihrer Mutter einzuziehen und sich um sie zu kümmern. Frau P. war immer eine sehr dynamische Person und sie hatte sich sehr bemüht um ihrer Mutter das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Während ihrem Krankenhausaufenthalt kümmern sich ihr Bruder und dessen Frau um Frau P. und ihre Mutter.

Momentan ist Frau P. bei Bewusstsein. Sie muss jedoch noch strikte Bettruhe einhalten. Sie weist eine Aphasie auf: sie kann sich nicht ausdrücken, aber sie versteht was man zu ihr sagt und sie antwortet auf einfache Befehle.

Während den Pflegemaßnahmen reagiert Frau P. heftig, weil sie erkennt dass ihre Bemühungen zu kooperieren erfolglos sind. Sie weint, sie stößt unartikulierte Laute aus und macht verneinende Kopfbewegungen. Danach lässt sie die Pflegen ohne jegliche Mithilfe über sich ergehen.

Sie stellen Rötungen am Steißbein und an den Fersen fest. Der Urin ist stark konzentriert.

Frau P isst nur sehr wenig und trinkt höchstens 1L/24Stunden.

Sie hatte noch keinen Stuhlgang seit ihrer Einlieferung ins Krankenhaus. Es sind auch keine Darmgeräusche vorhanden. Während der Anamnese konnte das Pflegeteam verstehen, dass Frau P. gewöhnlich einmal täglich eine Stuhlentleerung hat.

1.1. Argumentieren Sie die Hypothese der Pflegediagnose „Machtlosigkeit“ indem Sie alle Indizien der Patientin mit denen aus dem Buch vergleichen.

(8P)

1.2. Erklären Sie wie Sie vorgehen um diese Pflegediagnose zu validieren.

(4P)

2.1. Formulieren Sie eine reelle Pflegediagnose aus dem physischen Bereich.

(1P)

2.2. Zählen Sie 3 begünstigende Faktoren und die Merkmale dieser Pflegediagnose die Sie in dieser Situation vorfinden auf.

(5P)

2.3. Formulieren Sie ein Pflegeziel.

(2P)

2.4. Argumentieren Sie 3 Pflegemaßnahmen.

(6P)